# Antidiabétiques : quel traitement, quelle étape ?

Objectif d'HbA1c selon le profil, étape suivante, molécules adaptées au rein, insuline basale, sujet âgé.
EHPAD · FAM · EAM · MAS · IME — médecins DOTR, médecins coordonnateurs

FICHE PRATIQUE DOTR
MÉDICAMENTS & SÉCURITÉ
Mise à jour : Octobre 2026

**À RETENIR**

**Metformine d'abord. iSGLT2 ou AR GLP-1 quel que soit l'HbA1c si maladie CV, insuffisance cardiaque, MRC ou haut risque CV. Sujet âgé : éviter l'hypoglycémie avant tout — sulfamides et glinides à éviter chez le fragile, jamais chez le dépendant.**

*Sources : SFD 2025 (avis d'experts) · HAS 2024*

## 1 · Objectif d'HbA1c

| Profil | Objectif | Sous sulfamide, glinide ou insuline |
|---|---|---|
| **Adulte < 75 ans** | ≤ 7 % | ≤ 6,5 % si atteignable sans traitement hypoglycémiant |
| **Comorbidité sévère, espérance de vie < 5 ans, DFG < 30** | ≤ 8 % | Rester **> 7 %** |
| **> 75 ans en bonne santé** | ≤ 7 % | Éviter au maximum les hypoglycémies |
| **> 75 ans fragile** | ≤ 8 % | Rester **> 7 %** ; sulfamides et glinides à éviter |
| **> 75 ans dépendant, santé très altérée** | < 9 %<br>glycémies avant repas 1 à 2 g/L | Rester **> 7,5 %** sous insuline ; sulfamides et glinides : **jamais** |

*Sources : SFD 2025 (avis d'experts) · HAS 2024*

## 2 · L'arbre décisionnel du DT2

### ① AU DIAGNOSTIC

- Mesures hygiéno-diététiques puis **metformine** à doses progressives (2 à 3 g/j si toléré).
- **HbA1c ≥ 8,5 %** : bithérapie d'emblée avec la metformine (SFD ; HAS : 10 %).
- **HbA1c ≥ 10 %** : avis endocrinologue, fond d'œil, baisse progressive.
- **Soif, polyurie, amaigrissement** : insuline ; cétose ou hyperosmolarité → hôpital.

*Sources : SFD 2025 (avis d'experts) · HAS 2024*

### ② QUEL QUE SOIT L'HbA1c

- **Insuffisance cardiaque, MRC** : + **iSGLT2** (dapagliflozine, empagliflozine).
- **MCV athéromateuse** : + iSGLT2 ou **AR GLP-1** (préféré si AVC ou AOMI).
- **Obésité** (IMC ≥ 30) : + AR GLP-1 ou tirzépatide.
- MRC et iSGLT2 impossible : sémaglutide (bénéfice rénal démontré).

*Sources : SFD 2025 (avis d'experts) · HAS 2024*

### ③ INTENSIFIER (3 à 6 mois)

- Après metformine : **iSGLT2 > AR GLP-1 / tirzépatide > iDPP4 > sulfamide / glinide**.
- Bithérapie orale en échec : passer à **metformine + AR GLP-1 ou tirzépatide**, ou trithérapie orale.
- Sous AR GLP-1 : passer au tirzépatide, ou + iSGLT2, ou basale.
- Molécule qui baisse l'HbA1c de **< 0,5 %** : l'arrêter (sauf indication cardio-rénale).

*Sources : SFD 2025 (avis d'experts) · HAS 2024*

### ④ INSULINE BASALE

- **Analogue lent** ; glargine U300 ou dégludec si risque d'hypoglycémie nocturne.
- Début **6 à 10 U/j** ou 0,1 à 0,2 U/kg/j, à heure fixe.
- Titration **tous les 3 jours, ± 2 U** (± 10 % si > 40 U) ; cible au réveil **0,80–1,30 g/L**.
- Garder la metformine, **arrêter le sulfamide**.
- Glycémie au réveil dans la cible mais HbA1c haute, ou > 0,5 U/kg/j : + AR GLP-1 / tirzépatide (SFD) ou basal-plus (HAS) ; avis endocrinologue.

*Sources : SFD 2025 (avis d'experts) · HAS 2024*

### ⑤ SUJET ÂGÉ FRAGILE OU DÉPENDANT

- **Metformine (selon DFG) + iDPP4**, puis **une injection d'analogue lent**.
- Dépendant : éviter sulfamides, glinides et AR GLP-1 ; rapides seulement si HbA1c ≥ 9 %.
- Écart à l'objectif < 0,5 % : abstention possible (HAS).
- Hypoglycémies ou HbA1c sous le plancher : **désescalader** (arrêter sulfamide / glinide, réduire l'insuline).
- EHPAD : garder un capteur de glucose déjà posé ; alarme basse 0,80–1,00 g/L.

*Sources : SFD 2025 (avis d'experts) · HAS 2024*

### ⑥ HYPOGLYCÉMIE (< 0,70 g/L)

- **Conscient** : 15 g de sucre, recontrôle à 15 min, à répéter, puis collation.
- **Trouble de conscience** : rien par la bouche ; **glucagon** GlucaGen 1 mg SC/IM (0,5 mg si < 25 kg) ou Baqsimi 3 mg nasal ; appeler le 15.
- Sous sulfamide : hypoglycémie prolongée, surveiller plusieurs heures.
- **DT1** : l'insuline ne s'arrête jamais ; vomissements ou fièvre → cétonémie, avis.

*Sources : ADA/EASD 2021 · RCP (BDPM / EMA)*

Fiche pratique DOTR, octobre 2026. SFD 2025 (avis d'experts) et HAS 2024 (recommandation gradée) ; ne remplace ni le RCP ni l'avis du diabétologue. Outil interactif sur l'Espace VMS / DOTR.

Vision Moderne de la Santé

Docs On The Road
Construisons ensemble une santé qui vient à vous.

## 3 · Les molécules commercialisées et le rein (DFG en mL/min)

| Molécule · spécialités | Début → max | Rein | Remb. |
|---|---|---|---|
| **Metformine** · Glucophage, Stagid, génériques | 500–850 mg × 2–3 → 3 g/j | 45–59 : 2 g · 30–44 : 1 g · **< 30 : CI** | 65 % |
| **Dapagliflozine** · Forxiga | 10 mg/j | ne pas initier < 25 ; effet glycémique ↓ < 45 | 65 % |
| **Empagliflozine** · Jardiance | 10 → 25 mg/j | < 60 : 10 mg · ne pas initier < 20 | 65 % |
| **Canagliflozine** · Invokana | 100 → 300 mg/j | 30–59 : 100 mg · ne pas initier < 30 | 65 % |
| **Sémaglutide** · Ozempic | 0,25 → 0,5 → 1 mg/sem | pas d'adaptation · IR terminale : non recommandé | 30 % (BDPM) |
| **Dulaglutide** · Trulicity | 1,5 → 4,5 mg/sem | < 15 : non recommandé | 65 % |
| **Liraglutide** · Victoza | 0,6 → 1,8 mg/j | IR terminale : non recommandé | 65 % |
| **Tirzépatide** · Mounjaro | 2,5 → 15 mg/sem (paliers 4 sem) | pas d'adaptation | 65 % avec metformine (± SU ou basale) |
| **Sitagliptine** · Januvia, génériques | 100 mg/j | 30–44 : 50 mg · < 30 : 25 mg (non commercialisé) | 30 % |
| **Vildagliptine** · Galvus, génériques | 50 mg × 2/j | < 50 : 50 mg/j | 15 % |
| **Saxagliptine** · Onglyza, génériques | 5 mg/j | < 45 : 2,5 mg (non commercialisé) · éviter si IC | 15 % |
| **Gliclazide** · Diamicron LM, génériques | 30 → 120 mg/j | **IR sévère : CI** | 65 % |
| **Glimépiride** · Amarel, génériques | 1 → 6 mg/j | **IR sévère : CI** | 65 % |
| **Répaglinide** · NovoNorm, génériques | 0,5 mg/repas → 16 mg/j | utilisable jusqu'en IR terminale | 65 % |
| **Acarbose** · génériques | 50 → 100 mg × 3/j | ClCr < 25 : ne pas utiliser | 65 % |

*Sources : RCP (BDPM / EMA) · BDPM 14/10/2026*

### PRÉCAUTIONS QUI COMPTENT EN ESMS

- **Metformine** : arrêter pour un produit de contraste iodé ou une chirurgie, reprendre ≥ 48 h après si fonction rénale stable.
- **iSGLT2** : suspendre si maladie aiguë sévère, déshydratation, jeûne ; acidocétose possible avec une glycémie normale.
- **AR GLP-1, tirzépatide** : document d'accompagnement obligatoire pour le remboursement ; jamais avec un iDPP4 ; déshydratation si troubles digestifs.
- Vildagliptine : bilan hépatique tous les 3 mois la 1re année.

*Sources : RCP (BDPM / EMA) · Assurance Maladie 2025-2026*

### INSULINES (liste II, 65 %)

- **Basales** : glargine U100 (Lantus, Abasaglar, Semglee), **U300** (Toujeo), dégludec (Tresiba), détémir (Levemir), NPH (Insulatard, Umuline NPH).
- **Rapides** : NovoRapid, Fiasp, Humalog, Lyumjev, Apidra, Actrapid. Humalog / Lyumjev 200 : **jamais à la seringue**.
- **Mélanges** : NovoMix, Humalog Mix, Mixtard, Umuline Profil. **Xultophy** (dégludec + liraglutide) : max 50 doses.

Non commercialisés : pioglitazone, linagliptine, Rybelsus, Suliqua, insuline icodec.

*Sources : RCP (BDPM / EMA) · BDPM 14/10/2026*

Sources : SFD, prise de position sur les traitements de l'hyperglycémie dans le DT2 — 2025 (Darmon P et al., Méd Mal Métab 2025;19:630-662), avis d'experts ; HAS, Stratégie thérapeutique du patient vivant avec un diabète de type 2, recommandation de bonne pratique, mai 2024 ; RCP des spécialités (base de données publique des médicaments / EMA), rubriques 4.2 et 4.3 ; Base de données publique des médicaments, spécialités commercialisées et taux de remboursement, 14/10/2026 ; Assurance Maladie, AR GLP-1 : document d'accompagnement obligatoire (01/02/2025) ; tirzépatide remboursé dans le DT2 depuis le 15/06/2026 (arrêtés du 10/06/2026) ; Holt RIG et al., Management of type 1 diabetes in adults, consensus ADA/EASD, Diabetologia 2021.